



Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Ministerio de Salud y Protección Social

2026-08-19

Documento metodológico oficial | ClicSalud — Encuesta Nacional de Experiencia
del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Índice general

Presentación	4
1. Introducción	5
2. Antecedentes	8
2.1. Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud	8
2.2. Trayectoria de la medición de experiencia y satisfacción en el SGSSS (2003–2025)	9
2.2.1. Encuesta nacional 2017	9
2.2.2. Ranking de satisfacción EPS 2018	10
2.2.3. Evaluación 2020	10
2.2.4. Encuesta 2022	11
2.2.5. Encuesta 2023: énfasis en atención primaria en salud	11
2.2.6. Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: mediciones 2024 y 2025	11
2.3. Balance metodológico del ciclo 2017–2023	12
2.4. Síntesis comparativa de los diseños históricos	13
2.5. Referentes internacionales de medición de experiencia del usuario en salud	16
3. Objetivo y alcance	17
3.1. Objetivo general	17
3.2. Objetivos específicos	17
3.3. Alcance de la operación estadística	18

3.3.1. Fenómeno estudiado	18
3.3.2. Población objetivo	19
3.3.3. Unidades de observación	19
3.3.4. Territorio	19
3.3.5. Periodo de referencia	19
3.3.6. Dominios de análisis	19
4. Marco conceptual	20
4.1. Experiencia del usuario en salud	20
4.2. Dimensiones de la experiencia del usuario	20
4.3. Distinción entre experiencia del usuario y otros conceptos afines	21
5. Papel de las EPS e IPS	22
5.1. EPS como dato de identificación del usuario	22
5.2. EPS, IPS y gestor como categoría de clasificación del módulo	22
5.3. Mecanismo de participación: sin evidencia en los insumos técnicos disponibles	23
6. Limitaciones	24
6.1. Distinción entre error de muestreo y sesgos no muestrales .	24
6.2. Limitaciones del mecanismo de captación	25
6.3. Cobertura	25
6.4. Participación y no respuesta	25
6.5. Selección dentro de cuotas	25
6.6. Dependencia de las variables auxiliares	26
6.7. Limitaciones de la calibración	26
6.8. Limitaciones de la estimación de incertidumbre	26
6.9. Síntesis	26
Referencias	28

Presentación

El presente documento constituye el **Documento Metodológico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)**, operación estadística del *Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)*. El documento es elaborado por la **Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social** y constituye el referente metodológico para la revisión técnica, la validación institucional y la documentación de la operación.

Capítulo 1

Introducción

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuenta con antecedentes en Colombia que incluyen ejercicios desarrollados por la Defensoría del Pueblo y posteriores mediciones institucionalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas experiencias han permitido generar evidencia sobre diferentes dimensiones de la relación de los usuarios con los servicios de salud, entre ellas el acceso, la oportunidad, el trato y la satisfacción (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2018, 2020, 2022, 2023). La **Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)** se desarrolla en continuidad con estos antecedentes y busca fortalecer la generación sistemática de información sobre la experiencia de los usuarios con los servicios de salud que reciben.

La experiencia reportada por los usuarios constituye una fuente de información complementaria a los registros administrativos y a otros mecanismos de seguimiento del sistema de salud. Su medición permite identificar diferencias en la forma en que los usuarios acceden a los servicios, reciben atención, interactúan con las instituciones y valoran distintos aspectos del proceso de atención. En este sentido, la información obtenida mediante la ENUS constituye un insumo para el seguimiento y análisis de las condiciones de atención y para apoyar los procesos de evaluación y toma de decisiones en el sector salud.

La ENUS 2026 se estructura a partir de un cuestionario diseñado para recoger información sobre las diferentes dimensiones de la experiencia de los usuarios. La aplicación del instrumento se realiza mediante **ClicSalud**, herramienta de recolección en la que se implementan las preguntas, validaciones y reglas de navegación. La secuencia de aplicación se encuentra definida mediante un árbol de decisión que establece las condiciones de entrada, los saltos y las rutas que debe seguir cada participante de acuer-

do con sus características y respuestas. Esta estructura permite que no todos los participantes respondan necesariamente el mismo conjunto de preguntas y que la información obtenida corresponda a la ruta aplicable a cada caso.

La captación de participantes se desarrolla mediante un mecanismo de **muestreo por cuotas**, en el que las EPS e IPS participantes actúan como canales institucionales de promoción y captación de usuarios. La clasificación de los participantes y el control de las cuotas se realizan de acuerdo con las variables y categorías definidas para la operación. Este procedimiento determina la composición objetivo de la muestra y constituye un componente central del diseño de la encuesta, por lo que sus características, reglas de asignación y mecanismos de control se documentan de manera específica.

Una vez recolectada y validada la información, se conforma la base analítica sobre la cual se aplican los procedimientos de ponderación y **calibración por entropía**. Estos procedimientos permiten incorporar información auxiliar y ajustar los pesos de las observaciones de acuerdo con los totales de referencia definidos para la operación. A partir de los pesos calibrados se obtienen los estimadores de los indicadores de interés y se aplican los procedimientos establecidos para evaluar su incertidumbre y calidad estadística.

El presente **Documento Metodológico** describe de manera integrada los elementos que sustentan la ENUS 2026. En particular, documenta la población objetivo y las unidades de observación, el mecanismo de captación y clasificación de los participantes, el diseño y control de las cuotas, la estructura y aplicación del cuestionario, el árbol de decisión y sus rutas, el procesamiento y validación de la información, la construcción y calibración de los pesos, la estimación de los indicadores y los procedimientos para evaluar su incertidumbre y calidad.

El documento mantiene la correspondencia entre los diferentes componentes de la operación. Para ello, se establece la trazabilidad entre los objetivos de medición, las dimensiones e indicadores, las variables observadas, las preguntas del cuestionario, las rutas de aplicación, la base analítica y los procedimientos de estimación. Esta trazabilidad permite relacionar los resultados estadísticos con su origen dentro del instrumento y con las transformaciones realizadas durante el procesamiento y análisis de la información.

La organización del documento sigue la secuencia metodológica de la operación. Inicialmente se presenta la identidad y caracterización de la ENUS 2026 y se establece su marco general. Posteriormente se describen la población objetivo, el diseño de la encuesta, el mecanismo de captación, el instrumento de recolección y la estructura lógica del cuestionario. A continuación se desarrollan los procedimientos de procesamiento, ponderación,

calibración y estimación, así como la metodología para evaluar la incertidumbre y la calidad estadística de los resultados. Finalmente, se presentan las principales limitaciones de la operación y los anexos técnicos que contienen las especificaciones detalladas del cuestionario, el árbol de decisión, las cuotas, los indicadores y las matrices de trazabilidad.

La elaboración del documento se realiza a partir de los insumos metodológicos, operativos y técnicos vigentes de la ENUS 2026. Las decisiones metodológicas se documentan de manera explícita y, cuando la información disponible no permite establecer una definición, esta se identifica como **pendiente de definición**, evitando incorporar supuestos que no hayan sido establecidos formalmente para la operación.

En conjunto, el documento constituye el referente metodológico para comprender cómo se estructura la ENUS 2026, cómo se obtiene y procesa la información y cómo se transforma la información recolectada en resultados estadísticos.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1 Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud

La obligación de medir la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene un anclaje normativo explícito en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), establecido por el Decreto 1011 de 2006 (Ministerio de la Protección Social 2006). El SOGCS orienta sus acciones al mejoramiento de los resultados de la atención en salud centrados en el usuario —y no únicamente a la verificación de estructura o de procesos— y se articula en cuatro componentes: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. Entre las características esenciales que el SOGCS exige evaluar están la accesibilidad —la posibilidad del usuario de utilizar los servicios garantizados por el SGSSS— y la oportunidad —la posibilidad de obtener los servicios requeridos sin demoras que pongan en riesgo la vida o la salud—, dos dimensiones centrales de lo que mide ENUS 2026. Este marco normativo es el fundamento institucional que sostiene, desde 2006, la existencia de mediciones periódicas de la experiencia del usuario en el sistema de salud colombiano.

2.2 Trayectoria de la medición de experiencia y satisfacción en el SGSSS (2003--2025)

La medición sistemática de la satisfacción de usuarios del SGSSS tiene antecedentes en los estudios de la Defensoría del Pueblo, realizados en tres ocasiones —2003, 2005 y 2009— con representatividad para cada Empresa Promotora de Salud (EPS) en los regímenes contributivo y subsidiado, y aplicados a los usuarios en el momento de realizar algún trámite en las oficinas de la EPS (Defensoría del Pueblo de Colombia 2009). En paralelo, el entonces Ministerio de la Protección Social desarrolló el instrumento PECASUSS (Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud), con una línea de base en 2006 y mediciones de seguimiento en 2008 y 2010, orientado a evaluar el impacto del Programa de Reestructuración de Redes de Servicios de Salud sobre la calidad percibida por los usuarios de las instituciones intervenidas (Ministerio de la Protección Social 2008).

A partir de 2012 el MSPS institucionalizó mediciones anuales con diseño probabilístico multietápico y levantamiento presencial en hogares, cuyo desarrollo progresivo culminó en el ciclo 2017–2025 que se describe a continuación.

2.2.1 Encuesta nacional 2017

Diseño muestral. La edición de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017) es la referencia metodológica más documentada del ciclo y establece la arquitectura de diseño que orientó las ediciones posteriores. El diseño fue **probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados**, con tres etapas de selección anidadas:

- *Primera etapa — selección de municipios.* El territorio nacional se estratificó en tres grupos según la categoría municipal DNP: los 32 municipios capital de departamento más el Distrito Capital se incluyeron con certeza (Estrato 1); 23 municipios de mediano tamaño se seleccionaron aleatoriamente con probabilidad proporcional al tamaño (PPS) de la población afiliada (Estrato 2); y 40 municipios rurales y de menor tamaño se seleccionaron de la misma forma (Estrato 3). En total, 95 municipios constituyeron las unidades primarias de muestreo.
- *Segunda etapa — selección de manzanas.* Dentro de cada municipio seleccionado se procedió a la selección sistemática de manzanas o sectores censales proporcional al número de hogares del marco censal del DANE.
- *Tercera etapa — selección de personas.* En cada hogar visitado se identificaron los miembros que hubieran utilizado al menos un servicio de su EPS en los seis meses previos, y se seleccionó un informante

elegible mediante tabla de Kish o procedimiento aleatorio equivalente.

Población objetivo. Afiliados al SGSSS en los regímenes contributivo y subsidiado, de todas las edades, residentes en zonas urbanas y centros poblados del territorio nacional, con al menos un uso de servicio a través de la EPS en los seis meses anteriores a la entrevista. Se excluyeron afiliados a regímenes especiales (fuerzas militares, Ecopetrol, universidades públicas), beneficiarios de medicina prepagada y de planes complementarios.

Tamaño de muestra y trabajo de campo. Se obtuvieron 24.586 encuestas efectivas distribuidas en los 95 municipios de los 32 departamentos y el Distrito Capital. El trabajo de campo se realizó en julio y agosto de 2017 mediante entrevista personal cara a cara en hogares. El cuestionario articuló siete ejes temáticos: satisfacción global, oportunidad, acceso, trato digno, resolutivez, caracterización sociodemográfica y corresponsabilidad del usuario. El 72,6 % de los encuestados calificó positivamente su experiencia con la EPS, con variaciones significativas entre aseguradoras y entre regímenes.

2.2.2 Ranking de satisfacción EPS 2018

La edición de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social 2018) no constituyó una encuesta independiente sino un análisis secundario de los datos de la encuesta 2017 bajo un marco analítico renovado. El cambio central fue la sustitución de la dimensión “acceso” por la dimensión “trámites”, incorporando cinco nuevos indicadores sobre gestión de autorizaciones. El modelo quedó estructurado en 51 indicadores distribuidos en tres dimensiones de igual ponderación: oportunidad (33,3 %), satisfacción (33,3 %) y trámites (33,3 %). El proceso de cálculo aplicó estandarización lineal a la escala 0–100 y estimó diferencias significativas entre EPS mediante bootstrapping con 1.000 replicaciones, con un umbral de significancia de 0,092 puntos en la escala estandarizada.

2.2.3 Evaluación 2020

La evaluación de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020) enfrentó las restricciones operativas de la pandemia de COVID-19, que hicieron inviable el levantamiento presencial en hogares bajo el esquema tradicional. El diseño incorporó una modalidad híbrida: entrevistas presenciales en puntos de atención habilitados y captación remota asistida en municipios con restricciones de movilidad activas. La ventana de referencia mantuvo los seis meses previos a la entrevista e incluyó un módulo

específico sobre el impacto pandémico en el acceso a servicios electivos y controles crónicos. Esta edición evidenció deterioro significativo en los indicadores de acceso y oportunidad atribuible a las suspensiones temporales de servicios no urgentes.

2.2.4 Encuesta 2022

La edición de 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social 2022) introdujo una reestructuración del instrumento orientada a capturar diferencias en la experiencia del usuario según el tipo de servicio utilizado. El cuestionario se organizó en módulos diferenciados para medicina general, medicina especializada, urgencias, hospitalización, medicamentos y autorizaciones. El diseño muestral continuó siendo probabilístico, multietápico y estratificado, con entrevista presencial en hogares como modalidad principal.

2.2.5 Encuesta 2023: énfasis en atención primaria en salud

La encuesta de 2023 (Ministerio de Salud y Protección Social 2023) es la edición metodológicamente más elaborada del ciclo. Sus especificaciones técnicas son: diseño probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico (municipios, sectores censales y personas); entrevista personal presencial en hogares; instrumento de aproximadamente 75 preguntas organizadas en módulos temáticos; población objetivo de habitantes de todo el territorio nacional, todas las edades, en las seis macrorregiones del país; tamaño mínimo contractual de 12.096 encuestas efectivas, con 14.845 respuestas válidas procesadas; y desagregación por EPS de los regímenes contributivo y subsidiado no intervenidas para liquidar, y por seis regiones geográficas (Pacífico, Caribe, Central, Oriental, Bogotá y Orinoquía-Amazónica). El 72,9 % de los usuarios calificó su experiencia global como positiva, con diferencias regionales estadísticamente significativas.

2.2.6 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: mediciones 2024 y 2025

La medición más reciente del ciclo, inmediatamente anterior a ENUS 2026, corresponde al Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA) de la Oficina de Calidad del MSPS, que ha continuado produciendo mediciones anuales de satisfacción de usuarios sobre el sistema de salud colombiano. En 2024 el promedio nacional de satisfacción (respuestas “buena” o “muy buena”) fue de 73,5 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2024). En la medición de 2025 —realizada entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre de ese año, con 18.639 usuarios encuestados en las seis regiones

en que se divide el sistema de salud— el promedio nacional descendió cerca de 10 puntos porcentuales frente a 2024: 53 % de respuestas “buena”, 10 % “muy buena”, 28 % “ni buena ni mala” y 8 % en las categorías negativas (“mala” y “muy mala”); en 18 de las 26 EPS evaluadas la satisfacción disminuyó respecto del año anterior (Ministerio de Salud y Protección Social 2025). Estas dos mediciones consolidan, bajo la misma Oficina de Calidad que impulsa ENUS 2026, la continuidad institucional de la serie de medición de experiencia de usuario que esta operación busca renovar.

2.3 Balance metodológico del ciclo 2017--2023

Fortalezas. El ciclo 2017–2023 consolidó un conjunto de atributos que constituyen el piso técnico sobre el que se apoya ENUS 2026. El uso sistemático de diseños probabilísticos multietápico con estratificación geográfica y por régimen garantizó probabilidades de inclusión conocidas e inferencia basada en diseño a nivel nacional y por aseguradora. La modalidad de entrevista presencial en hogares minimizó los sesgos de autoselección propios de canales digitales no controlados. La producción de rankings con bootstrapping formal introdujo un marco de inferencia robusto para la comparación entre EPS. Y la continuidad del ciclo generó una serie de tiempo que habilita comparaciones interanuales en las dimensiones de satisfacción, oportunidad y trámites.

Limitaciones. El ciclo presenta cuatro limitaciones estructurales. La periodicidad anual impide detectar variaciones estacionales o deterioros que requieran intervención regulatoria en el corto plazo. La ventana retrospectiva de seis meses mezcla experiencias de períodos distintos, introduciendo heterogeneidad temporal y sesgo de recuerdo creciente para eventos ocurridos al inicio del semestre. La precisión de las estimaciones departamentales no fue uniforme: los departamentos con menor volumen de afiliación tendieron a producir estimaciones con coeficientes de variación superiores al umbral deseable del 15 %. Y el instrumento extenso y homogéneo generó carga cognitiva desigual y tasas de abandono diferenciadas entre perfiles de usuario.

Lecciones aprendidas. El ciclo deja cuatro lecciones que informan el diseño de ENUS 2026: la segmentación modular del instrumento por tipo de servicio mejora la pertinencia de las preguntas sin sacrificar cobertura temática agregada; el bootstrapping u otros métodos de replicación para inferencia deben estar integrados desde el diseño y no tratarse como un análisis ex-post; los dominios departamentales con menor afiliación requieren un esquema explícito de control de composición muestral para alcanzar la precisión estadística requerida; y la integración de registros administrativos del SGSSS —SISPRO y RIPS— como marco de referencia actualizado es operacionalmente viable y reduce el costo de construcción del marco.

2.4 Síntesis comparativa de los diseños históricos

La siguiente tabla resume las características de diseño de las principales mediciones de satisfacción del SGSSS, desde los antecedentes previos al ciclo MSPS hasta la medición más reciente disponible.

Cuadro 2.1: Principales mediciones de satisfacción del SGSSS: características de diseño, 2003–2025

Año	Instrumento	Población objetivo	Diseño muestral	Muestra	Dominios
2003/05/09	Encuestas Defensoría del Pueblo	Usuarios de EPS en capitales y municipios seleccionados	No probabilístico; cuotas por afiliación regional	N/D	Regional (parcial)
2006/08/10	PECASUSS	Usuarios de hospitales intervenidos por el Programa de Reestructuración de Redes	Línea de base 2006 + seguimiento 2008 y 2010	N/D	Instituciones intervenidas
2012–2016	Encuesta anual MSPS	Afiliados SGSSS (contrib., subs.) con uso en 6 meses previos	Probabilístico, estratificado, multietápico; hogares	N/D	Nacional, régimen, grandes regiones
2017	Encuesta de Satisfacción EPS	Afiliados SGSSS con uso en 6 meses (excl. especiales y prepagada)	Probabilístico, trietápico, estratificado (3 estratos DNP); 95 UPM	24.586	Nacional, régimen, EPS, 32 dptos. + Bogotá
2018	Ranking de Satisfacción EPS	Ídem 2017 (análisis secundario)	Mismo diseño 2017; bootstrap (1.000 replicaciones)	24.586 (datos de 2017)	EPS, régimen, departamento
2020	Evaluación de Servicios EPS	Afiliados SGSSS con uso en 6 meses	Probabilístico, multietápico, estratificado; híbrido presencial/remoto	N/D	Nacional, régimen
2022	Encuesta de Satisfacción EPS	Afiliados SGSSS con uso reciente	Probabilístico, multietápico; módulos por tipo de servicio	N/D	Nacional, régimen, EPS

Año	Instrumento	Población objetivo	Diseño muestral	Muestra	Dominios
2023	Encuesta de Satisfacción con énfasis en APS	Habitantes del territorio nacional, todas las edades	Probabilístico, trietápico, estratificado, conglomerados	14.845 (mín. contractual 12.096)	Nacional, 6 regiones, EPS activas
2024	Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA)	Usuarios del sistema de salud colombiano	No reportado en las fuentes públicas consultadas	N/D	Nacional, EPS
2025	Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA)	Usuarios del sistema de salud colombiano, 6 regiones	No reportado en las fuentes públicas consultadas	18.639	Nacional, 6 regiones, 26 EPS evaluadas

2.5 Referentes internacionales de medición de experiencia del usuario en salud

La medición de la experiencia del usuario en los sistemas de salud no es una práctica exclusiva de Colombia. Distintos organismos y agencias han desarrollado marcos e instrumentos comparables que constituyen un referente metodológico complementario para ENUS 2026.

En Estados Unidos, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) desarrolla desde 1995 el programa Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS), un conjunto de encuestas estandarizadas que preguntan a pacientes y afiliados por su experiencia con los proveedores de salud —en particular sobre comunicación y facilidad de acceso a los servicios— y que habilitan comparaciones entre proveedores y a lo largo del tiempo (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

La Organización Mundial de la Salud introdujo, en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2000, el concepto de *responsiveness* (capacidad de respuesta) de los sistemas de salud: la capacidad del sistema de responder a las expectativas no clínicas legítimas de la población —respeto a la dignidad, autonomía, confidencialidad, atención oportuna, disponibilidad de comodidades básicas, elección de proveedor, acceso a redes de apoyo social y claridad en la comunicación— y desarrolló un instrumento aplicado en países de ingresos bajos, medios y altos (World Health Organization 2000).

Más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló la iniciativa Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS), la primera encuesta internacional de experiencias y resultados reportados por pacientes de atención primaria mayores de 45 años, con información de más de 107.000 pacientes en más de 1.800 centros de atención primaria de 19 países en su primer ciclo (2017–2025) (OECD 2025).

Estos referentes —nacionales e internacionales— comparten con ENUS 2026 el reconocimiento de que la experiencia reportada por el usuario es una dimensión de la calidad en salud que no puede inferirse exclusivamente de registros administrativos o clínicos, y que requiere instrumentos de medición directa, periódica y comparable en el tiempo.

Capítulo 3

Objetivo y alcance

3.1 Objetivo general

Medir la experiencia de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con los servicios de salud que reciben, mediante una operación estadística de aplicación continua, y generar información periódica y comparable que sirva de insumo para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la atención por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y de las demás entidades de inspección, vigilancia y control del sistema.

3.2 Objetivos específicos

1. **Medir las dimensiones conceptuales de la experiencia del usuario** —accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad, tal como se definen en el marco conceptual (4)— en los distintos tipos de servicio con los que interactúa el usuario, en correspondencia con las características que el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) exige evaluar (Ministerio de la Protección Social 2006).
2. **Producir información con mayor frecuencia y oportunidad** que el ciclo de mediciones anuales que caracterizó al SGSSS entre 2012 y 2025 (2), de modo que las variaciones en la experiencia del usuario puedan detectarse e informar oportunamente los ciclos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y del propio MSPS.

3. **Reducir el sesgo de recuerdo** asociado a ventanas de referencia amplias, acercando el momento de la entrevista al momento del uso efectivo del servicio de salud, mediante la recolección continua a través de *ClicSalud* (??).
4. **Generar información con capacidad de desagregación** por las variables de clasificación que finalmente se adopten para la operación (sexo, edad, geografía, zona y régimen de afiliación) y por tipo de servicio utilizado, en la medida en que el diseño muestral (??) y el tamaño de muestra efectivo lo permitan.
5. **Mantener comparabilidad temporal** con la serie histórica de mediciones de satisfacción y experiencia del usuario del SGSSS (2), preservando en la medida de lo posible dimensiones y preguntas equivalentes que permitan interpretar la evolución de los indicadores.
6. **Documentar de manera reproducible** la relación entre el instrumento de recolección, el árbol de decisión que gobierna su navegación, el mecanismo de selección y clasificación de los participantes, la construcción de los pesos analíticos y la estimación de los indicadores, de forma que la operación pueda auditarse y replicarse.

Estos objetivos corresponden a lo que el instrumento de ENUS 2026 —el cuestionario aplicado a través de *ClicSalud*, navegado mediante el árbol de decisión— efectivamente captura: no se formulan objetivos sobre dimensiones o poblaciones que el instrumento no cubre.

3.3 Alcance de la operación estadística

Esta sección delimita, a nivel general, qué mide ENUS 2026, a quién mide y en qué extensión geográfica y temporal. La definición operativa completa de cada elemento —con sus categorías exactas y sus fuentes— se desarrolla en los capítulos de población objetivo y marco de referencia (??) y de diseño muestral (??).

3.3.1 Fenómeno estudiado

La experiencia del usuario con los servicios de salud que recibe a través del SGSSS, entendida como el conjunto de percepciones y valoraciones que el usuario reporta sobre su interacción con el sistema —accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad (4)— y no los resultados clínicos de la atención en sí mismos.

3.3.2 Población objetivo

Personas afiliadas al SGSSS que hayan utilizado servicios de salud a través de su entidad, cuya afiliación se valida contra la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) al momento de acceder a *ClicSalud*. La caracterización completa de la población objetivo, la población de referencia y la relación entre ambas —incluida la definición exacta de la ventana de uso que hace elegible a una persona— se desarrolla en ??.

3.3.3 Unidades de observación

La unidad de observación es el usuario individual del sistema de salud, identificado y validado a través de *ClicSalud*. La operación no recolecta información a nivel de hogar ni de institución prestadora; las EPS, IPS y gestores farmacéuticos operan como referentes de identificación y clasificación del usuario, no como unidades observadas (5).

3.3.4 Territorio

Cobertura nacional. La desagregación geográfica específica —departamental o por región— depende de la variable de clasificación que finalmente se adopte para la operación y se resuelve en el diseño muestral (??).

3.3.5 Periodo de referencia

A diferencia del ciclo histórico de mediciones —levantado en ventanas discretas, anuales o semestrales (2)—, ENUS 2026 opera mediante recolección continua a través de *ClicSalud*: el usuario accede a la encuesta en función de su uso reciente de servicios de salud, sin que la operación dependa de un único levantamiento puntual en el año. La ventana exacta de uso que hace elegible a un usuario se define en ??; los cortes de análisis y publicación de resultados se definen en el diseño muestral (??) y no alteran el carácter continuo de la recolección.

3.3.6 Dominios de análisis

Nacional; geográfico (en la desagregación que se adopte); régimen de afiliación; sexo; grupo de edad; zona; y tipo de servicio utilizado, según el módulo que asigna el árbol de decisión. La precisión estadística alcanzable en cada dominio depende del tamaño de muestra efectivo por celda y se evalúa en el diagnóstico de calibración (??).

Capítulo 4

Marco conceptual

Este capítulo define los conceptos necesarios para interpretar la experiencia del usuario en salud tal como la mide ENUS 2026, a partir de las definiciones institucionales disponibles: el marco normativo del SOGCS y los referentes internacionales de medición de experiencia de usuario ya identificados en el capítulo de antecedentes (2).

4.1 Experiencia del usuario en salud

La experiencia del usuario es el conjunto de percepciones y valoraciones que una persona construye a partir de su contacto directo con los servicios de salud, distinta de la satisfacción global (una valoración sintética y retrospectiva) y distinta de los resultados clínicos (que dependen de la condición de salud, no solo del proceso de atención). El marco de *responsiveness* de la Organización Mundial de la Salud formaliza esta distinción: la capacidad de respuesta de un sistema de salud se evalúa por su desempeño frente a expectativas no clínicas legítimas de la población, verificables únicamente a través del reporte directo del usuario (World Health Organization 2000).

4.2 Dimensiones de la experiencia del usuario

A partir del marco de *responsiveness* (World Health Organization 2000), de los estándares CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995) y del propio marco normativo del SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006), se identifican las siguientes dimensiones conceptuales, que ENUS 2026 mide a través de su cuestionario (ver ??):

- **Accesibilidad.** La posibilidad efectiva del usuario de utilizar los servicios garantizados por el SGSSS, definida explícitamente como característica de calidad exigible por el SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006).
- **Oportunidad.** La posibilidad de obtener los servicios requeridos sin demoras que pongan en riesgo la vida o la salud del usuario, también definida por el SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006) y presente como dimensión central en el ciclo histórico de medición del MSPS (ver 2).
- **Trato digno.** El respeto a la dignidad, la autonomía y la confidencialidad del usuario durante la atención, dimensión central del marco de *responsiveness* de la OMS (World Health Organization 2000).
- **Comunicación.** La claridad de la información suministrada al usuario y la facilidad de comunicación con el prestador, dimensión explícita tanto en el marco de la OMS (World Health Organization 2000) como en los estándares CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).
- **Resolutividad.** La capacidad del servicio recibido de resolver efectivamente la necesidad de salud que motivó el contacto del usuario con el sistema, dimensión presente de forma constante en el ciclo histórico de medición del MSPS (ver 2).

4.3 Distinción entre experiencia del usuario y otros conceptos afines

Experiencia vs. satisfacción. La satisfacción es una valoración global y subjetiva (“¿qué tan satisfecho quedó?”), mientras que la experiencia se refiere a hechos concretos ocurridos durante la atención (“¿tuvo que esperar más de 30 minutos?”, “¿el personal le explicó el procedimiento?”). ENUS 2026, como operación de experiencia del usuario, prioriza el reporte de hechos observables sobre la valoración subjetiva agregada, siguiendo el enfoque de los instrumentos CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Experiencia vs. resultado clínico. Un resultado clínico favorable no implica una buena experiencia (un usuario puede recuperarse de una enfermedad y, aun así, haber sido tratado sin dignidad o haber esperado un tiempo excesivo), y viceversa. ENUS 2026 mide la segunda, no la primera.

Unidad de observación. El concepto de experiencia del usuario, tal como se define en este capítulo, se aplica al usuario individual del SGSSS en su contacto con un servicio de salud específico. La correspondencia entre este concepto y las unidades efectivamente observadas por ENUS 2026 —población objetivo, población de referencia, población accesible— se desarrolla en el capítulo de población objetivo (??).

Capítulo 5

Papel de las EPS e IPS

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos aparecen en los insumos técnicos de ENUS 2026 —la aplicación ClicSalud y el árbol de decisión— en dos funciones distintas, ninguna de las cuales corresponde a una unidad de muestreo seleccionada probabilísticamente.

5.1 EPS como dato de identificación del usuario

En ClicSalud, la EPS del usuario se captura como parte de su identificación: la aplicación presenta un listado de EPS (EPS_LIST) del cual el usuario selecciona la propia antes de continuar. Esta selección identifica al usuario dentro del sistema, de forma análoga a las demás variables de identificación (documento, municipio, régimen), y no constituye un mecanismo de selección de la EPS como unidad muestral.

5.2 EPS, IPS y gestor como categoría de clasificación del módulo

El árbol de decisión organiza sus módulos por el tipo de actor institucional que prestó el servicio evaluado —EPS, IPS o gestor farmacéutico—, cada uno con submódulos según el tipo de servicio (consulta externa, urgencias, internación, servicios ambulatorios, canales farmacológicos y no farmacológicos). Es decir, EPS/IPS/gestor funcionan como una variable de clasificación que determina qué formulario específico responde el usuario según con qué tipo de actor tuvo contacto, de la misma manera en que

otras variables trazadoras determinan la ruta del cuestionario (ver ??). El desarrollo completo de esta estructura de módulos se documenta en el capítulo de flujo y rutas del cuestionario.

5.3 Mecanismo de participación: sin evidencia en los insumos técnicos disponibles

Los insumos técnicos revisados —el mock de ClicSalud y los archivos de datos del árbol de decisión (02_arbol/data/*.js)— no documentan un mecanismo por el cual las EPS o las IPS actúen como canal institucional para invitar, promover o facilitar activamente la participación de sus usuarios en ENUS 2026 (por ejemplo, envío de invitaciones, códigos de acceso distribuidos en puntos de atención, o listados de usuarios remitidos por el actor institucional). Conforme a la instrucción de no presentar mecanismos no respaldados por los insumos, este documento no describe tal mecanismo. Si en la operación real las EPS o las IPS cumplen un papel activo de promoción o facilitación del acceso a la encuesta, esa información debe ser suministrada por el equipo metodológico ENUS para incorporarla aquí con la evidencia correspondiente.

En síntesis, con la evidencia disponible, las EPS y las IPS participan en ENUS 2026 como categoría de identificación del usuario y como variable de clasificación del cuestionario —no como unidades de muestreo ni, hasta donde documentan los insumos técnicos, como canales activos de reclutamiento.

Capítulo 6

Limitaciones

Este capítulo documenta las limitaciones metodológicas de ENUS 2026 como operación estadística, a un nivel general y transversal. Las limitaciones específicas del muestreo por cuotas se desarrollan en ??.

6.1 Distinción entre error de muestreo y sesgos no muestrales

Es necesario distinguir dos fuentes de discrepancia entre una estimación de ENUS 2026 y el valor poblacional que pretende representar:

- **Error de muestreo / variabilidad de estimación.** Es la variabilidad que surge de observar solo una muestra y no la totalidad de la población. Bajo el diseño de ENUS 2026, esta variabilidad se cuantifica mediante replicación de pesos calibrados por entropía (ver ??) y se expresa en los intervalos de incertidumbre reportados junto a cada estimador.
- **Sesgos y errores no muestrales.** Son discrepancias sistemáticas que no desaparecen al aumentar el tamaño de muestra: sesgo de selección, sesgo de cobertura, sesgo de no respuesta, errores de medición del instrumento, errores de captura. Estos no quedan reflejados en los intervalos de incertidumbre y deben documentarse explícitamente, como se hace en las secciones siguientes.

6.2 Limitaciones del mecanismo de captación

La captación de usuarios de ENUS 2026 no es un muestreo aleatorio: la inclusión de un usuario en la muestra depende de que sea clasificado como elegible y de que decida participar, no de un mecanismo de selección con probabilidad conocida (ver ??). En consecuencia, no existe una probabilidad de inclusión π_i definida para cada usuario de la población objetivo, y los estimadores no pueden interpretarse como insesgados en el sentido del muestreo probabilístico clásico.

6.3 Cobertura

La cobertura de ENUS 2026 está limitada a los usuarios que son identificables y clasificables a través de la aplicación ClicSalud y de las variables trazadoras que utiliza el árbol de decisión (ver ??). Usuarios sin acceso al canal de recolección, o cuyas variables de clasificación no puedan determinarse, no tienen posibilidad de quedar representados en la muestra, con independencia de cuál sea su experiencia real con el sistema de salud.

6.4 Participación y no respuesta

La participación en ENUS 2026 depende de la decisión voluntaria del usuario contactado o identificado. No existe garantía de que los usuarios que efectivamente participan sean representativos, en sus variables no observadas, de los usuarios que no participan. En particular, la propensión a participar puede estar asociada a la intensidad de la experiencia vivida —positiva o negativa—, lo que introduce un riesgo de sesgo de no respuesta que las cuotas y la calibración por entropía no garantizan eliminar, en la medida en que ese riesgo dependa de variables no observadas o no incluidas como variables auxiliares.

6.5 Selección dentro de cuotas

Dentro de cada celda de cuota, la selección del usuario específico que efectivamente responde no sigue un mecanismo aleatorio documentado en los insumos disponibles (ver limitaciones específicas en ??). Esto significa que, aun cuando la composición agregada de la muestra coincida con la cuota objetivo en las variables de control, pueden persistir diferencias sistemáticas entre los usuarios seleccionados y el resto de la celda en variables no controladas.

6.6 Dependencia de las variables auxiliares

La calibración por entropía corrige la muestra respecto de los totales poblacionales de las variables auxiliares utilizadas (sexo, edad, régimen, departamento, zona; ver ??). Esta corrección es efectiva únicamente en la medida en que el sesgo de selección esté correlacionado con esas variables. Si existen factores no observados que influyen simultáneamente en la probabilidad de participar y en las respuestas sustantivas del cuestionario —por ejemplo, la intensidad de la experiencia, el nivel de alfabetización digital, o el acceso a dispositivos y conectividad—, la calibración no corrige el sesgo asociado a esos factores.

6.7 Limitaciones de la calibración

La calibración por entropía no elimina los sesgos de selección. Reconstruye la coincidencia de la muestra con los totales poblacionales conocidos en las variables auxiliares utilizadas, pero no convierte una muestra no probabilística en una muestra aleatoria, y no corrige sesgos en variables que no forman parte de la calibración. El diagnóstico de calibración (ver ??) permite evaluar el ajuste logrado, pero no sustituye una evaluación directa de representatividad en variables no auxiliares.

6.8 Limitaciones de la estimación de incertidumbre

El método de replicación de pesos calibrados por entropía adoptado para ENUS 2026 (ver ??) cuantifica la variabilidad asociada al remuestreo y a la recalibración, bajo los supuestos del mecanismo de réplica definido. No cuantifica la incertidumbre asociada a los sesgos no muestrales descritos en las secciones anteriores. Un intervalo de incertidumbre estrecho es compatible con una estimación sesgada si el sesgo no muestral es de magnitud mayor que la variabilidad de muestreo capturada por las réplicas.

6.9 Síntesis

Las limitaciones descritas en este capítulo no invalidan a ENUS 2026 como operación estadística, pero sí acotan la interpretación de sus resultados: las estimaciones deben leerse como aproximaciones ajustadas a la estructura poblacional conocida en las variables de calibración, sujetas a sesgos

no muestrales no cuantificados, y no como estimaciones insesgadas en el sentido de un diseño probabilístico. Esta distinción debe mantenerse explícita en cualquier producto derivado de ENUS 2026.

Referencias

Las referencias citadas a lo largo de este documento se listan a continuación, generadas automáticamente a partir de `referencias.bib`.

Agency for Healthcare Research and Quality. 1995. *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)*. <https://www.ahrq.gov/cahps/index.html>.

Defensoría del Pueblo de Colombia. 2009. *Evaluación de los Servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) desde la Perspectiva del Usuario*. Defensoría del Pueblo de Colombia.

Ministerio de la Protección Social. 2006. *Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Ministerio de la Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto/%201011/%20de/%202006.pdf.

Ministerio de la Protección Social. 2008. *PECASUSS: Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud*. Ministerio de la Protección Social.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2017. *Informe Encuesta de Satisfacción EPS 2017*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Informe-encuesta-satisfaccion-eps-2017.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2018. *Ranking de Satisfacción EPS 2018. Sistema de Evaluación y Calificación de Actores*. Ministerio de Salud y Protección Social — Oficina de Calidad. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. *Encuesta de Evaluación*

de los Servicios de las EPS: Informe Final 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-eps-2020-minsalud.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2022. *Encuesta de Satisfacción de Servicios de las EPS 2022*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/encuesta-satisfaccion-servicios-eps-2022.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2023. *Resultados de la Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano con Énfasis en Atención Primaria en Salud*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/resultados-encuesta-satisfaccion-usuarios-sistema-salud-colombiano-enfasis-atencion-primaria.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2024. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024*. Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Calidad. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2025. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2025*. Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Calidad. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

OECD. 2025. *Does Healthcare Deliver? Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/does-healthcare-deliver_c8af05a5-en.html.

World Health Organization. 2000. *The World Health Report 2000: Health Systems – Improving Performance*. World Health Organization.